12. IL CUORE : DIASTOLE & SISTOLE

DURATA : 05:06 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora le dinamiche essenziali dei movimenti sistolici e diastolici del cuore, concentrandosi sul loro impatto sull'energia corporea e sulle emozioni. Imparerete a osservare gli orientamenti verticali e orizzontali del cuore, che possono rivelare aspetti cruciali della salute emotiva dei vostri pazienti. I concetti di looping ventricolare e di interazione con altri sistemi organici come il fegato e i polmoni mostrano come il cuore mantenga una pressione regolatrice nel suo ambiente fasciale. Tecniche pratiche di valutazione manuale del cuoio fasciale e dei movimenti permettono di applicare queste nozioni in un contesto terapeutico, svelando anche il legame tra il cuore e il diaframma per un buon funzionamento ritmico e metabolico.

13 - IL CUORE: DIASTOLE & SISTOLE

Il **cuore** immagazzina **energia** in un ambiente **fasciale**, sostenendo così la sua **elettricità**, sia nella sua fase ascendente che discendente.

Esiste una **predominanza innata** in alcune persone, che possono manifestare una funzione **sistolica** o **diastolica**. Un equilibrio tra queste due funzioni è normalmente richiesto. Il cuore ripete il suo movimento embrionale in modo abbastanza diretto.

MOVIMENTI DEL CUORE E IMPLICAZIONI EMOTIVE

Un movimento specifico può essere percepito. Ad esempio, le persone troppo orientate verso un movimento di **sistole** sono spesso alla ricerca, ma possono anche esaurirsi rapidamente. Al contrario, altre partono da questo punto e cercano costantemente un punto di appoggio inferiore.

IL LOOPING VENTRICOLARE E LE FASI CARDIACHE

Il cuore effettua un **looping** caratteristico, dove il sistema **ventricolare**, inizialmente superiore, diventa inferiore, con un punto di appoggio cruciale tra gli **atri** e i **ventricoli**.

- **Durante la sistole:**

* Il cuore effettua una **salita**.

* Realizza un movimento di **supinazione**.

* Tende a **verticalizzarsi**.

* Procedere a una **detorsione**.

È in questo momento che l'**aorta** si apre per accogliere tutto il sangue, provocando una **congestione**.

- **Durante la diastole (discesa):**

* Tutto il sangue dell'aorta viene espulso nel sistema.

A volte è facile confondere il movimento sistolico con il movimento di discesa. La sistole è il momento dell'**eiezione**. Quando il cuore ridiscende, si **riempie** di nuovo.

Quando il volume viene espulso, la pressione nel sistema dell'arco aortico aumenta. Al momento della discesa, il cuore si riempie mentre espelle l'aorta.

ORIENTAMENTO DEL CUORE: VERTICALIZZAZIONE VS. ORIZZONTALIZZAZIONE

Avete l'impressione che il cuore tenda a **verticalizzarsi** o a **orizzontalizzarsi**? Si verticalizza e sale, o si orizzontalizza e scende?

PUNTI DI APPOGGIO PER L'OSSERVAZIONE

Prenderemo tre punti di appoggio:

1. A livello dello **spazio aortico** (secondo spazio intercostale).

2. A livello dello **spazio polmonare**.

3. L'**eminenza ipotenar** si poserà sulla punta del cuore.

I SISTEMI INFLUENTI DEL CUORE

Il cuore reagisce in funzione di due grandi sistemi che gli sono molto vicini e tende ad aiutarli al massimo:

- Il **fegato**
- Lo **stomaco**
- I **polmoni**
- I **reni**

Cerca sempre di mantenere questa pressione nel suo ambiente. Il cuore è un **regolatore di volume**. Bisogna considerare il cuore come una grossa arteria che si prolunga con l'aorta, come un **octopus**.

MOVIMENTI DI SUPINAZIONE E PRONAZIONE

Avremo un movimento di **supinazione**, poi un movimento di **pronazione**.

VALUTAZIONE MANUALE E REATTIVITÀ FASCIALE

Osserveremo l'ambiente e come è organizzato. Poi, posizioneremo le mani a livello del fegato e osserveremo la sua reazione su un piano **fasciale**.

L'aorta, se la si osserva bene a livello anatomico, parte in realtà abbastanza indietro, il che la rende difficile da visualizzare. Tuttavia, condivide un ambiente fasciale comune con i **bronchi** e l'**esofago**, che si inseriscono a livello di una vertebra spesso in adattamento.

LE ZONE RITMICHE E LA RELAZIONE DIAFRAMMATICA

Esistono:

- Una zona **neurosensoriale**.
- Una zona **ritmica**.
- Una zona **metabolica**.
- Una zona **urogenitale**.

Per un buon movimento, il cuore deve avere una buona relazione con il **diaframma**. Esiste una relazione diretta tramite la continuità fasciale dell'arco e dell'aorta.

Ricordate il passaggio molto profondo dell'aorta, dove i **pilastri diaframmatici** si inseriscono da una parte e dall'altra. Per lavorare il cuore, è essenziale che il diaframma sia **aperto** e **morbido**. Non dimenticate l'altro passaggio importante a livello dell'esofago.

APPLICAZIONE PRATICA: SEGUIRE I MOVIMENTI FASCIALI

Abbiamo studiato il **fulcro embrionale pre-pattern** che si posiziona a livello della linea primitiva, a livello del coccige, con il punto di arrivo.

Ora, posizioniamo la mano a livello del cuore e lasciamola seguire il movimento fasciale. Il tessuto, se siete attenti, vi indicherà se il cuore pende più verso la sistole o verso la diastole.

È il mio fegato che reagisce? È in relazione al mio stomaco? O è in relazione ai miei reni? (Tre livelli). Poi, osserveremo se questo può riequilibrarsi rispetto a questa osservazione.